



unex centro
universitário
de excelência

Propedêutica Médica II

Exame Físico Segmento Cefálico II

Segmento Cefálico II

- Ouvido
- Nariz e seios paranasais
- Boca e anexos (glândulas salivares)
- Laringe e Traqueia
- Tireoide e Paratireoides



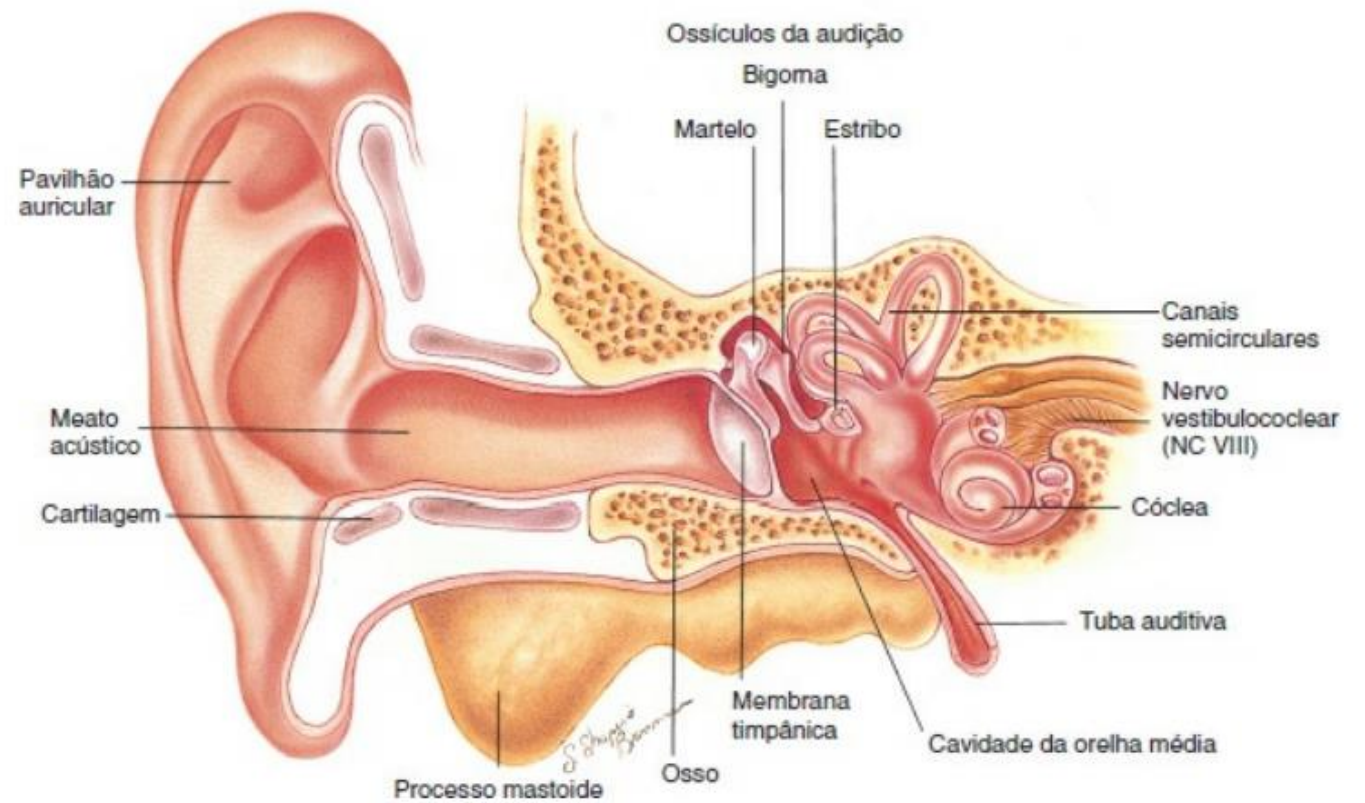
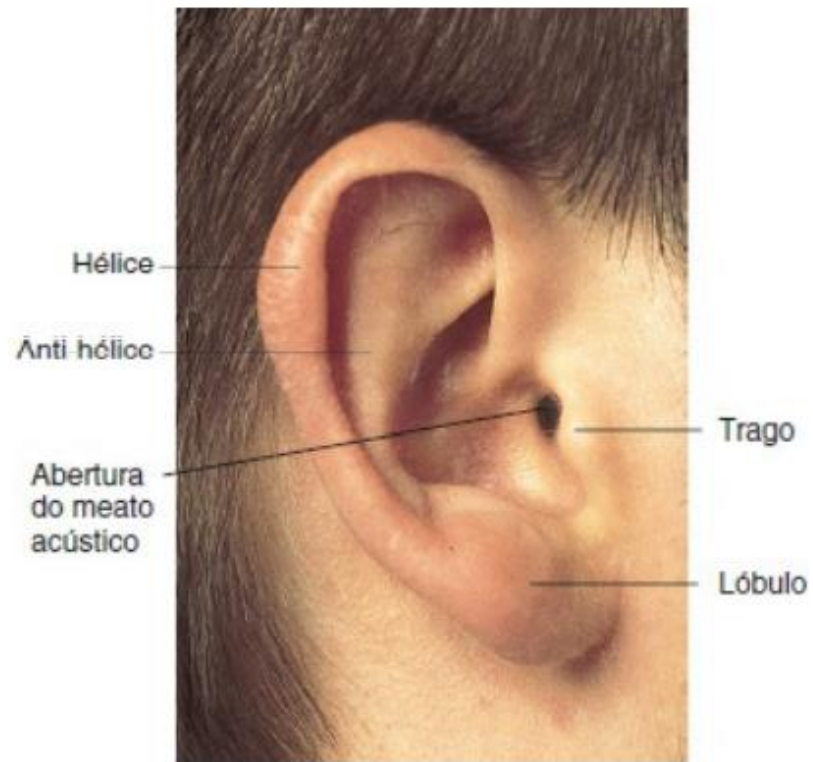
Objetivos da aula de hoje!

OUVIDO

O Aparelho auditivo divide-se em três porções - orelha externa, média e interna ou labirinto:

- ☐ A orelha externa compreende o pavilhão auricular e o meato acústico.
- ☐ Na orelha média preenchida por ar, os ossículos da audição.
- ☐ A orelha interna engloba a cóclea, os canais semicirculares e a extremidade distal do nervo vestibulococlear.





Exame Clínico

Essencial para o raciocínio clínico, a anamnese inicia-se pela identificação, em que se obtêm informações importantes que possibilitam avaliar o perfil do paciente em relação à sua saúde.



SINAIS E SINTOMAS

Hipoacusia
e anacusia

Tontura e
vertigem

Zumbido

Otalgia

Otorreia

Otorragia

Prurido

Hipoacusia e anacusia

Principal queixa relacionada com a audição. Significa perda parcial ou total de audição que diminua a inteligibilidade da mensagem falada.

Deve ser sempre avaliada quanto a:

- Lateralidade (uni ou bilateral);
- Início (insidioso, rapidamente progressivo ou abrupto);
- Intensidade, se parcial (hipoacusia) ou total (anacusia);
- Tempo de duração (dias, semanas, meses ou anos);

Hipoacusia e anacusia

Deve ser sempre avaliada quanto a:

- Constância, intermitência ou flutuação ao longo do dia;
- Início, antes ou após aquisição da linguagem oral (pré ou póslingual);
- Sintomas associados, zumbido, tontura, plenitude aural e acometimento de outros pares cranianos, como o nervo facial.

Tontura e Vertigem

Denominações utilizadas pelos pacientes como equivalentes, mas uma avaliação clínica correta permite diferenciá-las, o que é fundamental no raciocínio diagnóstico.

Pontos importantes a investigar:

- Tempo de evolução, aguda (menos de 1 semana) ou crônica;
- Recorrente ou autolimitada;
- Periodicidade;

Tontura e Vertigem

Pontos importantes a investigar:

- Características da tontura (sensação rotatória caracteriza a vertigem). Relato de flutuação; cabeça vazia; sensação de escurecimento visual, pré-síncope; instabilidade ou desequilíbrio não deve ser confundido com vertigem;
- Sintomas associados (hipoacusia, zumbido, cefaleia, náuseas, vômito);
- Fatores desencadeantes (movimentos ou posição da cabeça; esforço físico; alimentação; estresse).

Zumbido

Sensação de som na ausência de estímulo sonoro externo.

Dados a serem analisados:

- Localização (unilateral, bilateral ou na cabeça);
- Características (apito, chiado, grave, agudo, pulsação);
- Tempo de evolução;
- Modo de início (insidioso, abrupto, após episódio de surdez súbita ou episódio de tontura);
- Fatores de melhora ou piora (movimentação da cabeça; ingestão de alimentos como chocolate, alimentos condimentados, uso de cafeína);
- Grau de incômodo (leve, moderado, intenso);

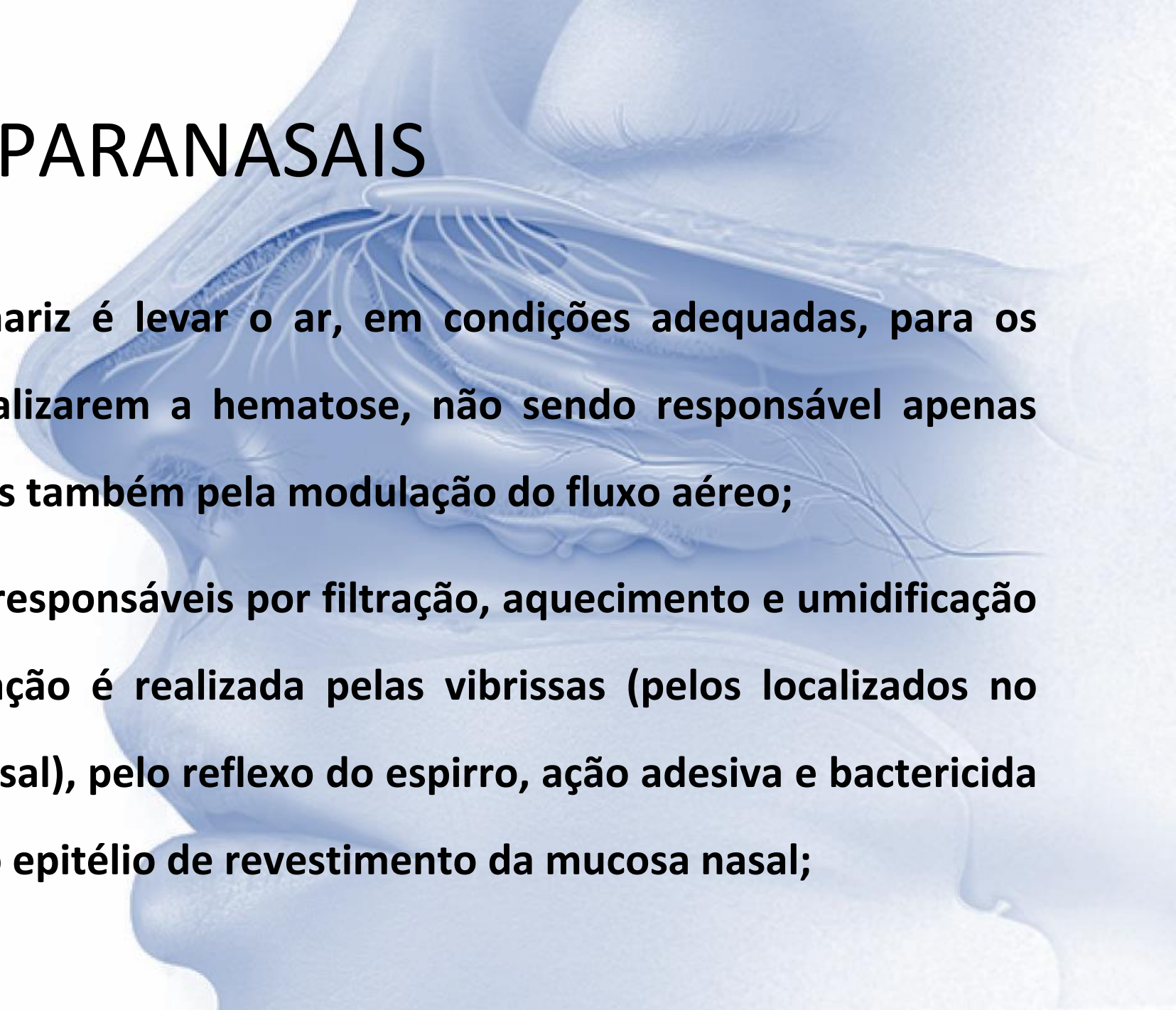
Zumbido

Dados a serem analisados:

- Sintomas associados: tontura, plenitude aural, perda auditiva, cefaleia, cervicalgia e distúrbio da articulação temporomandibular;
- Doenças sistêmicas (hipertensão arterial, diabetes, hiper ou hipotireoidismo);
- Tabagismo, etilismo, consumo excessivo de doces;
- Medicamentos (todos os grupos medicamentosos podem causar zumbido, entretanto, alguns são mais comuns, como: ácido acetilsalicílico, antiinflamatórios, aminoglicosídeos e antidepressivos);
- Tratamentos realizados.

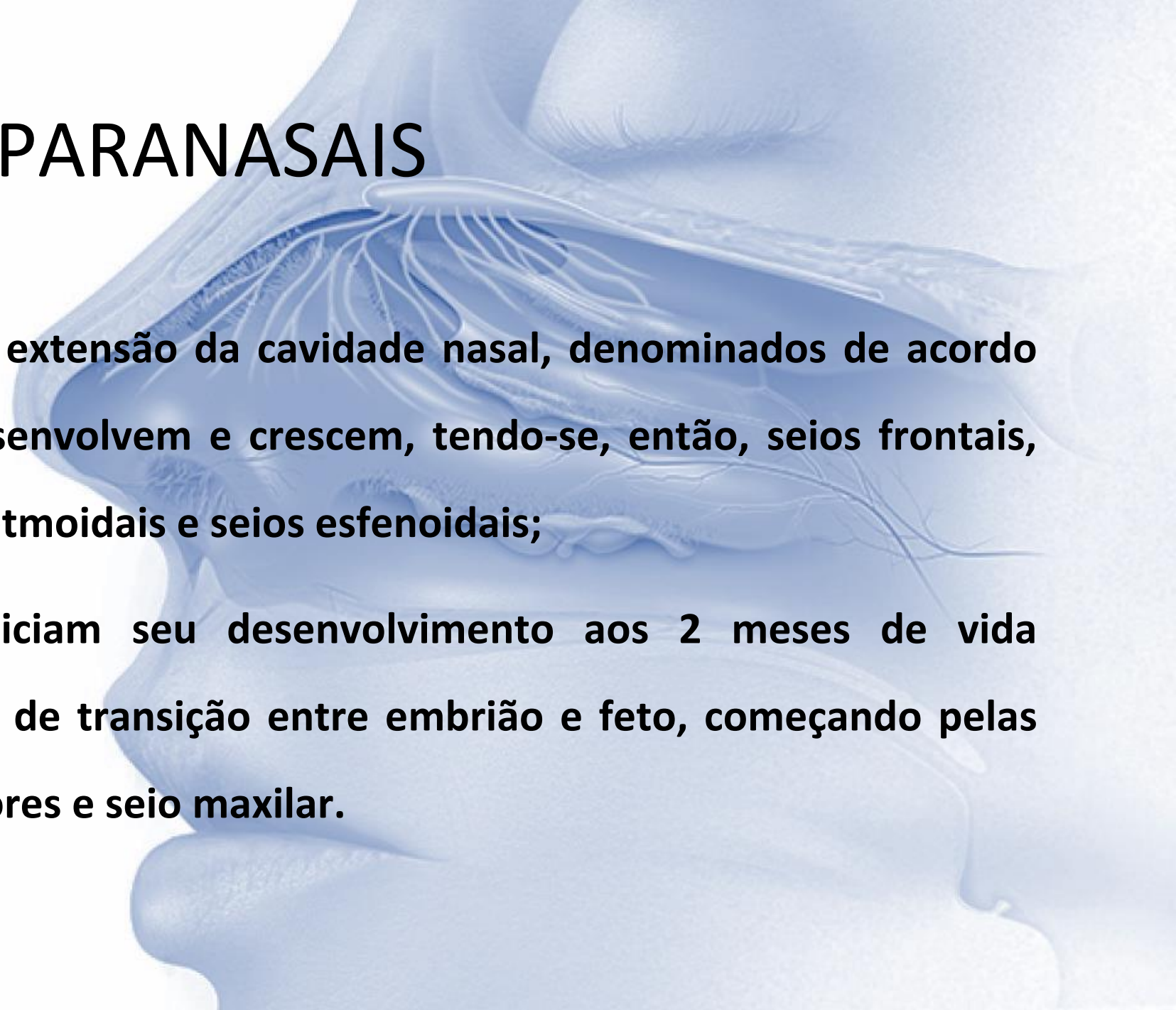
NARIZ E SEIOS PARANASAIS

- A principal função do nariz é levar o ar, em condições adequadas, para os alvéolos pulmonares realizarem a hematose, não sendo responsável apenas pela passagem do ar, mas também pela modulação do fluxo aéreo;
- As cavidades nasais são responsáveis por filtração, aquecimento e umidificação do ar inspirado. A filtração é realizada pelas vibrissas (pelos localizados no vestíbulo da cavidade nasal), pelo reflexo do espirro, ação adesiva e bactericida do muco e pelos cílios do epitélio de revestimento da mucosa nasal;



NARIZ E SEIOS PARANASAIS

- Os seios paranasais são extensão da cavidade nasal, denominados de acordo com o osso onde se desenvolvem e crescem, tendo-se, então, seios frontais, seios maxilares, células etmoidais e seios esfenoidais;
- Os seios paranasais iniciam seu desenvolvimento aos 2 meses de vida intrauterina, no período de transição entre embrião e feto, começando pelas células etmoidais anteriores e seio maxilar.

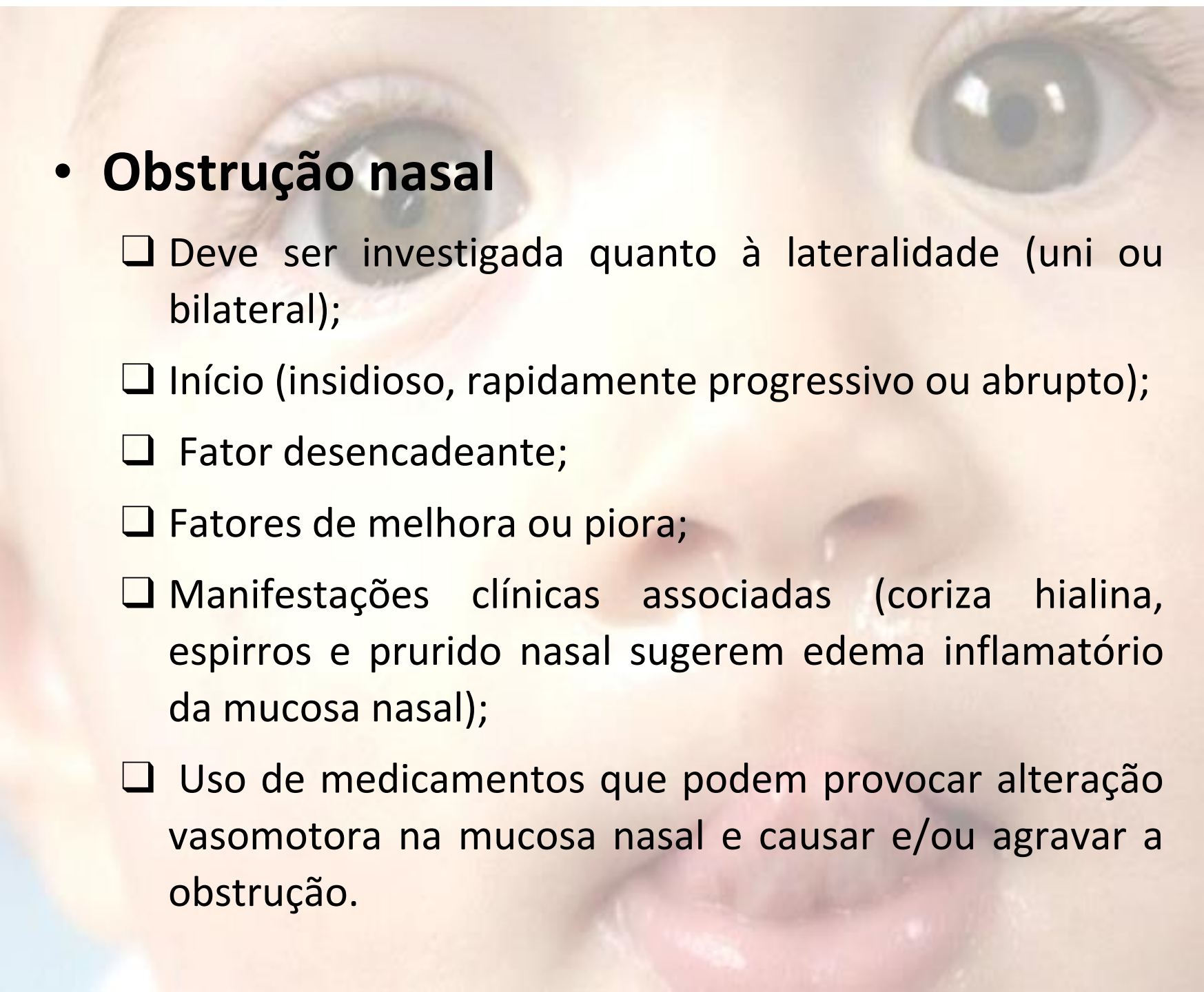


EXAME CLÍNICO

Na anamnese, registram-se os dados da identificação, antecedentes pessoais e antecedentes familiares, além dos sintomas como obstrução nasal, hiposmia ou anosmia, rinorreia, epistaxe e alteração do olfato.

- Obstrução nasal
- Rinorreia
- Alteração do olfato
- Epistaxe.

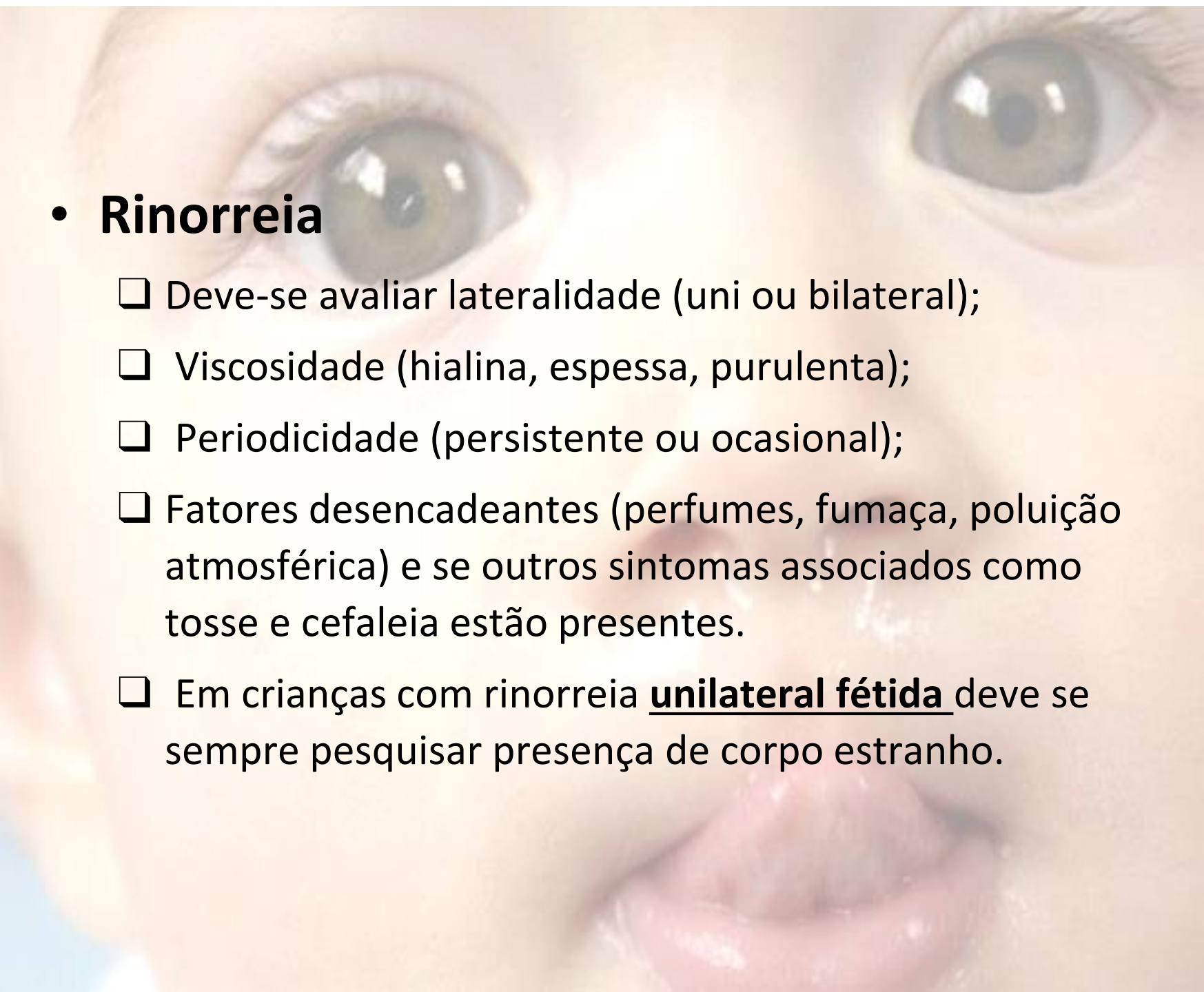




SINAIS E SINTOMAS

- **Obstrução nasal**

- ☐ Deve ser investigada quanto à lateralidade (uni ou bilateral);
- ☐ Início (insidioso, rapidamente progressivo ou abrupto);
- ☐ Fator desencadeante;
- ☐ Fatores de melhora ou piora;
- ☐ Manifestações clínicas associadas (coriza hialina, espirros e prurido nasal sugerem edema inflamatório da mucosa nasal);
- ☐ Uso de medicamentos que podem provocar alteração vasomotora na mucosa nasal e causar e/ou agravar a obstrução.

A close-up, slightly blurred photograph of a child's face, focusing on the eyes and nose. The child has light-colored eyes and a pink nose.

SINAIS E SINTOMAS

- **Rinorreia**

- ☐ Deve-se avaliar lateralidade (uni ou bilateral);
- ☐ Viscosidade (hialina, espessa, purulenta);
- ☐ Periodicidade (persistente ou ocasional);
- ☐ Fatores desencadeantes (perfumes, fumaça, poluição atmosférica) e se outros sintomas associados como tosse e cefaleia estão presentes.
- ☐ Em crianças com rinorreia **unilateral fétida** deve se sempre pesquisar presença de corpo estranho.



SINAIS E SINTOMAS

- **Alteração do olfato**

- ☐ Anosmia (perda completa da olfação);
- ☐ Hiperosmia (aumento da olfação);
- ☐ Hiposmia (diminuição da olfação);
- ☐ Disosmia (distorção da percepção olfatória, podendo ser subdividida em parosmia, quando há um estímulo ambiental, e fantosmia, sem estímulo ambiental, que é uma alucinação olfatória).

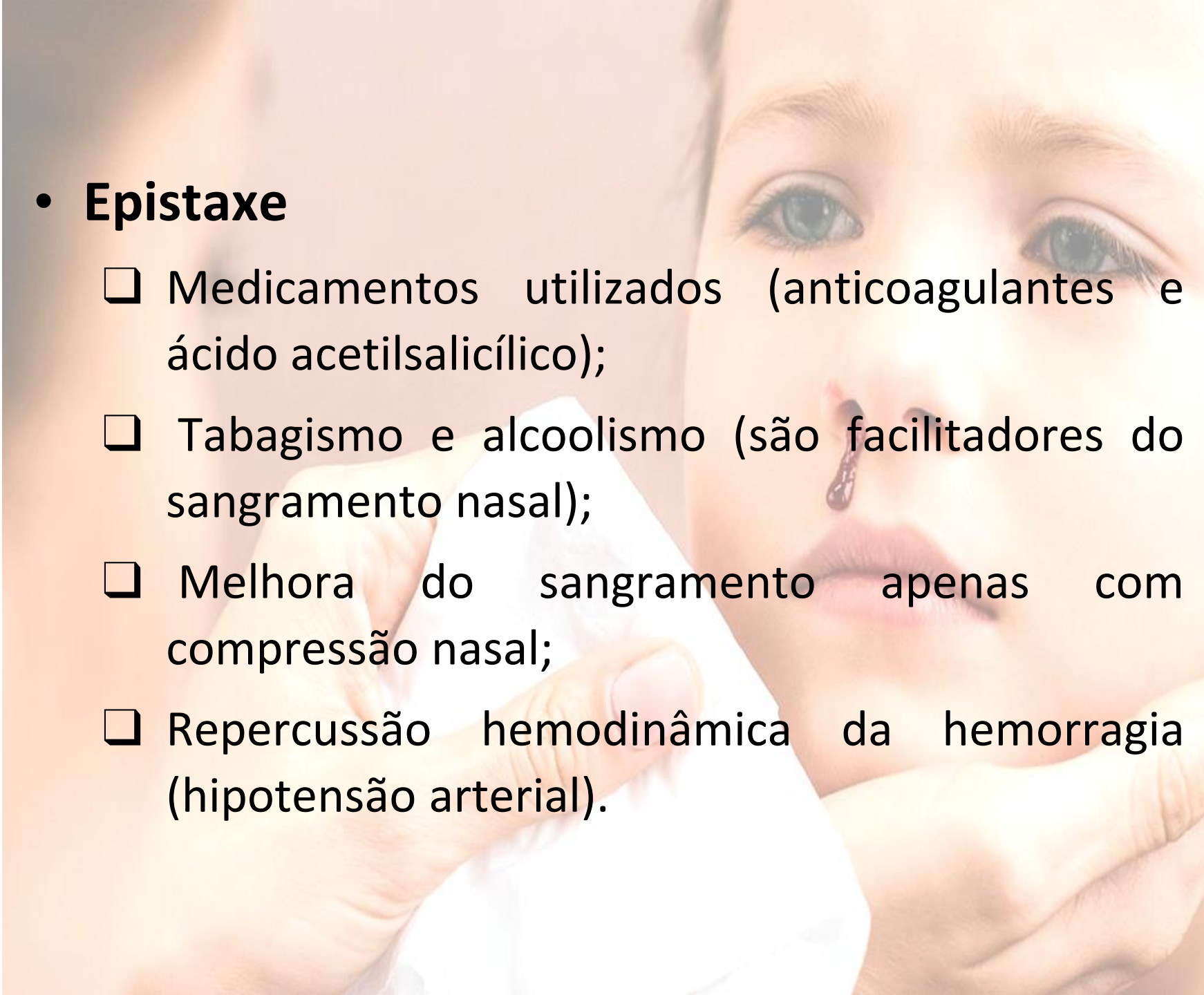
SINAIS E
SINTOMAS

- **Epistaxe**

- ☐ Lateralidade (uni ou bilateral);
- ☐ Tempo de evolução;
- ☐ Quadros clínicos semelhantes anteriores;
- ☐ Fatores associados ao início do sangramento (trauma, infecções de vias respiratórias superiores, rinite);
- ☐ Comorbidades (hipertensão arterial e coagulopatias são consideradas como facilitadoras do sangramento nasal);

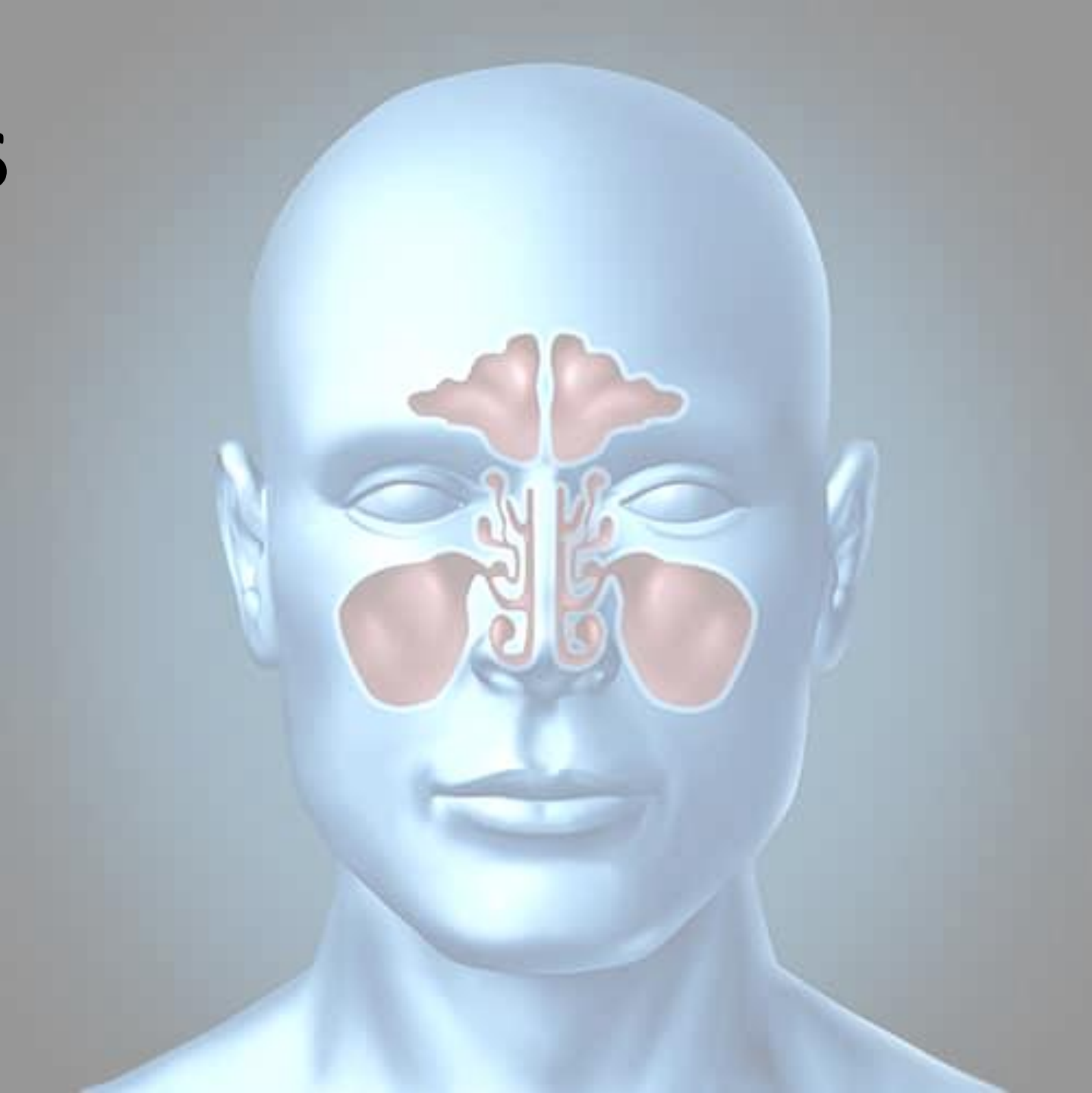
SINAIS E
SINTOMAS

- **Epistaxe**

- ☐ Medicamentos utilizados (anticoagulantes e ácido acetilsalicílico);
 - ☐ Tabagismo e alcoolismo (são facilitadores do sangramento nasal);
 - ☐ Melhora do sangramento apenas com compressão nasal;
 - ☐ Repercussão hemodinâmica da hemorragia (hipotensão arterial).
- 

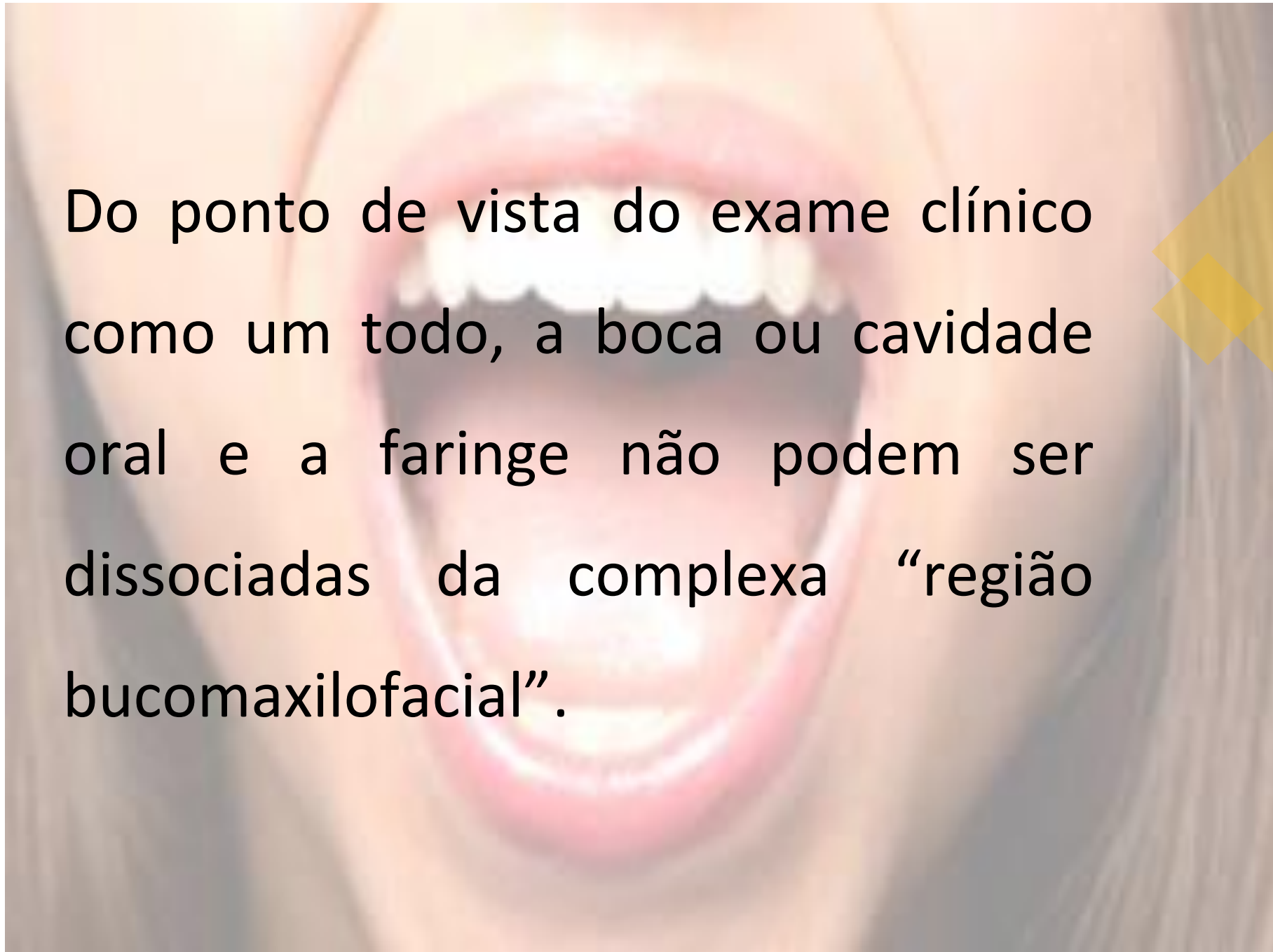
SEIOS PARANASAIS

A simples compressão dolorosa dos seios frontais e maxilares permite suspeitar a presença de sinusite aguda, um diagnóstico essencialmente clínico.



BOCA E GLÂNDULA S SALIVARES

Do ponto de vista do exame clínico como um todo, a boca ou cavidade oral e a faringe não podem ser dissociadas da complexa “região bucomaxilofacial”.



BOCA E GLANDULAS SALIVARES

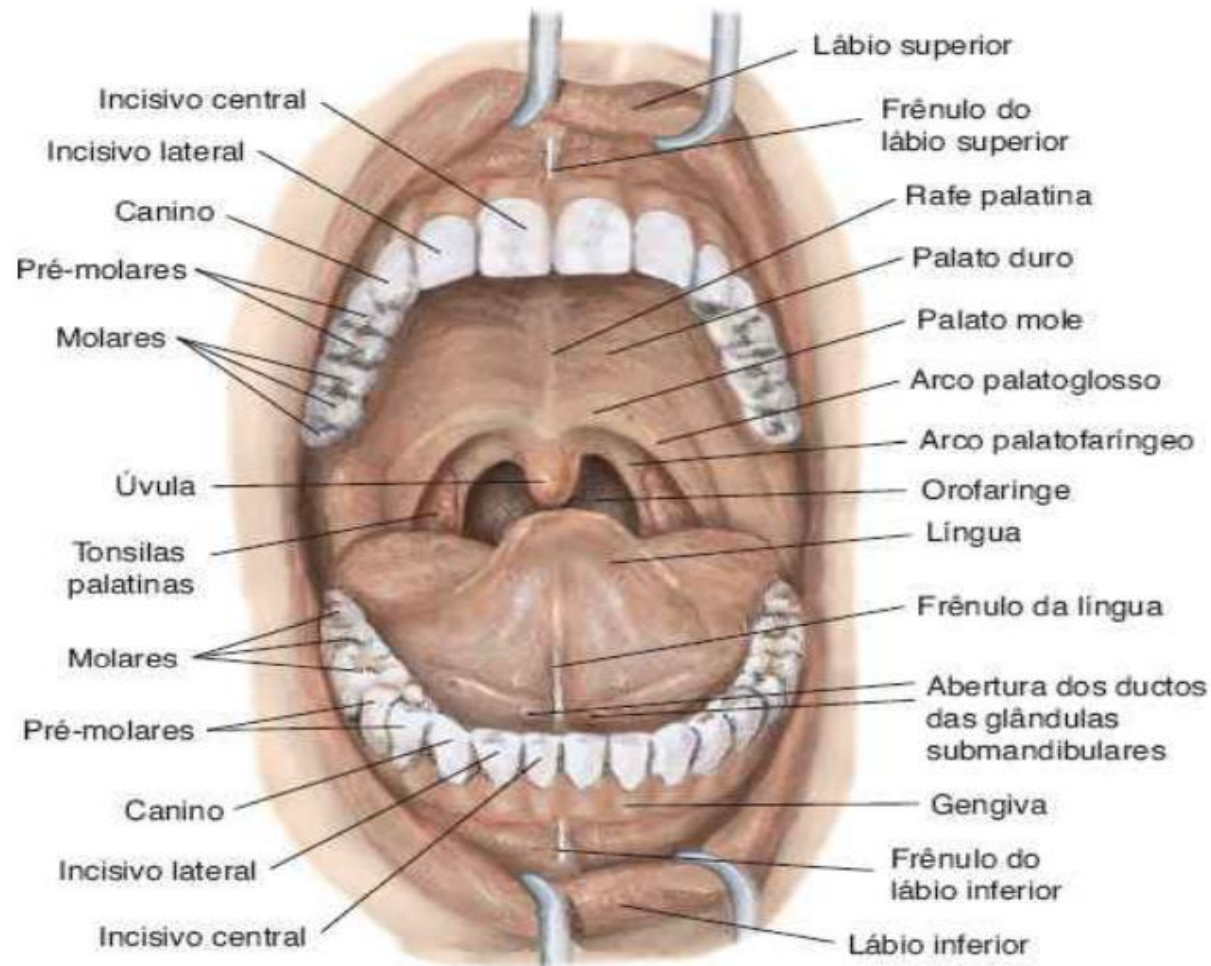
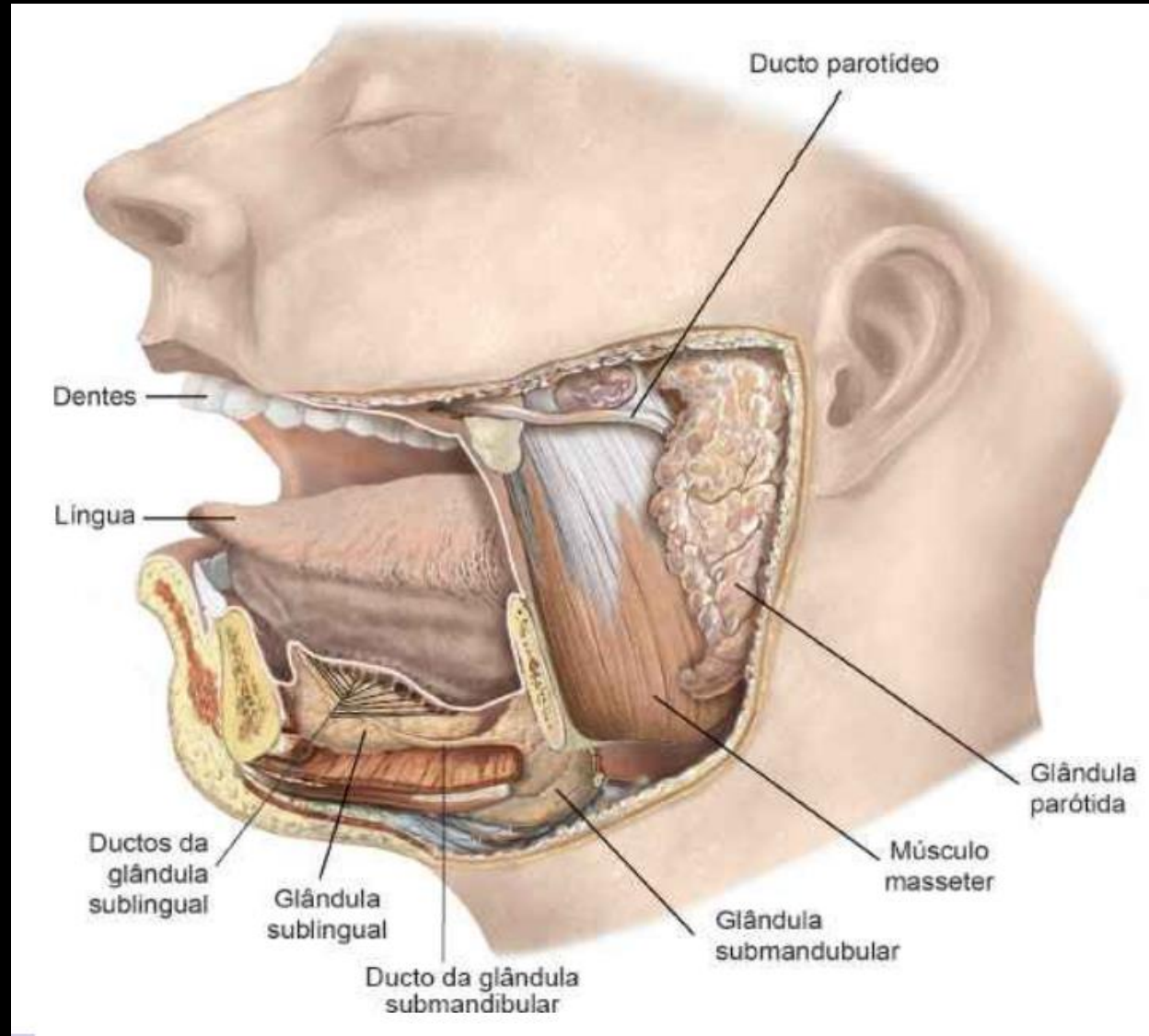


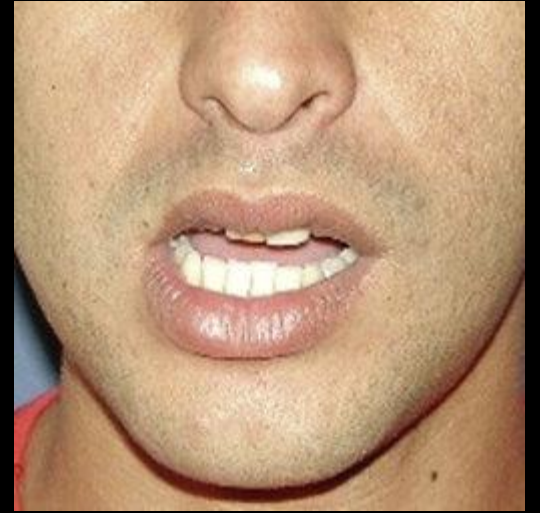
Figura 66.1 Representação esquemática da cavidade bucal e anexos. (Adaptada de Wolf-Heidegger – Atlas de Anatomia, 6ª ed., 2006.)

BOCA E GLÂNDULAS SALIVARES



Extrabucal

O exame extrabucal inclui a investigação dos linfonodos superficiais da região de cabeça e pescoço, forma e simetria das estruturas da região bucomaxilofacial, que podem estar relacionadas com alterações do desenvolvimento, má oclusão dentária, alterações e lesões musculoesqueléticas, articulares (ATM), dos seios da face e das glândulas salivares.



Durante os movimentos da mandíbula, a palpação propicia a percepção tátil de assimetrias da cabeça da mandíbula, estalidos e crepitações articulares, que podem originar alterações intra-articulares. Avalia-se, também, o grau de abertura da boca, desvios, sinais de tumefação e dor.

As regiões correspondentes às glândulas parótidas e submandibulares são avaliadas quanto à simetria e à coloração da pele, alterações que podem indicar sialoadenites agudas ou crônicas e neoplasias.



Lábios

Os lábios (superior e inferior) devem ser inspecionados e palpados bidigitalmente para se averiguar coloração, forma, textura, flexibilidade, assim como presença de lesões.

A cor, a largura e o formato variam de acordo com a etnia e as características genéticas.



Figura 3.36 Angioedema de Quinck nos lábios



Figura 3.37 Síndrome de Peutz-Jeghers: manchas hiper-crômicas nos lábios associadas à polipose gastrointestinal intestinal



Figura 3.38 Queilite angular em anemia ferropriva

MUCOSA JUGAL

Em condições normais, a mucosa jugal ou da bochecha tem uma coloração róseo-avermelhada mais homogênea que a da língua.

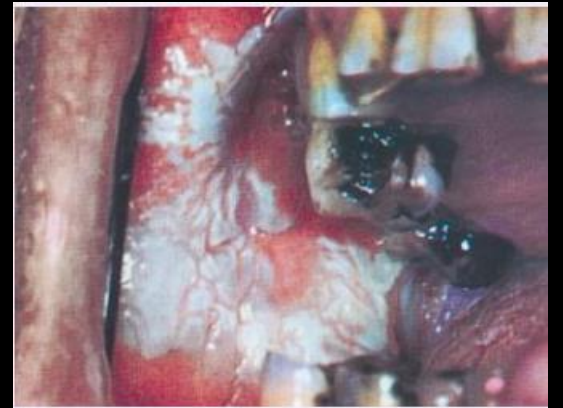


PALATO DURO E PALATO MOLE

Para a inspeção do palato o paciente deve inclinar sua cabeça para trás e abrir a boca, sob iluminação adequada (em toda a sua extensão). Em condições normais o palato duro apresenta-se com coloração rósea pálida, esbranquiçada, com uma textura firme.

Já o palato mole apresenta coloração rósea mais intensa que o palato duro.

As lesões mais frequentes no palato duro são: ulcerações traumáticas (trauma químico, mecânico e térmico), candidíase, estomatite nicotínica, neoplasias de glândulas salivares menores (aumento de volume com ou sem ulceração), fendas palatinas, sarcoma de Kaposi.



Assoalho bucal

É examinado pela inspeção, seguido por palpação bimanual. Deve-se solicitar ao paciente que levante a língua, para permitir visualização direta dos tecidos na linha média do soalho.



Os tecidos devem apresentar-se hidratados e bem vascularizados.

Reborda alveolar:

Trata-se da porção óssea da maxila e mandíbula que contém os dentes e seus tecidos de suporte (alvéolo, ligamento periodontal, gengiva inserida).

A perda precoce dos dentes leva a reabsorção da reborda com dificuldade para reabilitação com próteses. Sua avaliação deve ser feita por inspeção visual direta e indireta, bem como pela palpação, nas suas superfícies vestibular e lingual.

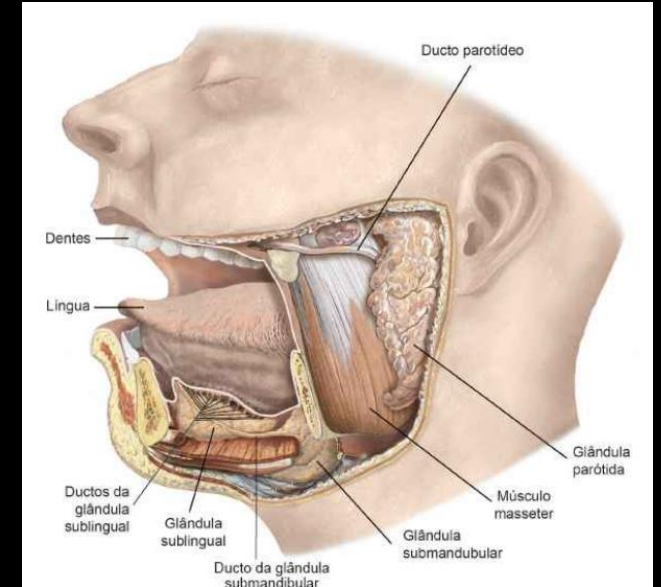


Glândulas salivares

As glândulas salivares menores, espalhadas em toda mucosa bucal, e as maiores (parótidas, submandibulares e sublinguais), em condições normais, não são visíveis e a saliva é límpida.

Nos processos inflamatórios e na obstrução dos ductos salivares apresentam-se intumescidas e dolorosas.

A estimulação manual dessas glândulas, conhecida como “ordenha”, permite uma avaliação quali e quantitativa da saliva, observando os seus pontos de drenagem (carúnculas linguais e parotídeas).



Glândulas salivares

A drenagem de saliva com grumos mucoides, redução ou ausência de gota translúcida de saliva, pode revelar doença obstrutiva (sialólitos) e/ou infecciosas (sialoadenites). Neoplasias benignas e malignas das glândulas salivares têm comportamento biológico semelhante – crescimento lento e insidioso, razão pela qual a suspeita clínica deve ser avaliada com critério.

Dos tumores benignos de glândulas salivares o adenoma pleomórfico é o mais comum, sendo a glândula parótida a de maior prevalência. Dos malignos o carcinoma mucoepidermoide está entre os mais prevalentes, especialmente nas glândulas menores.



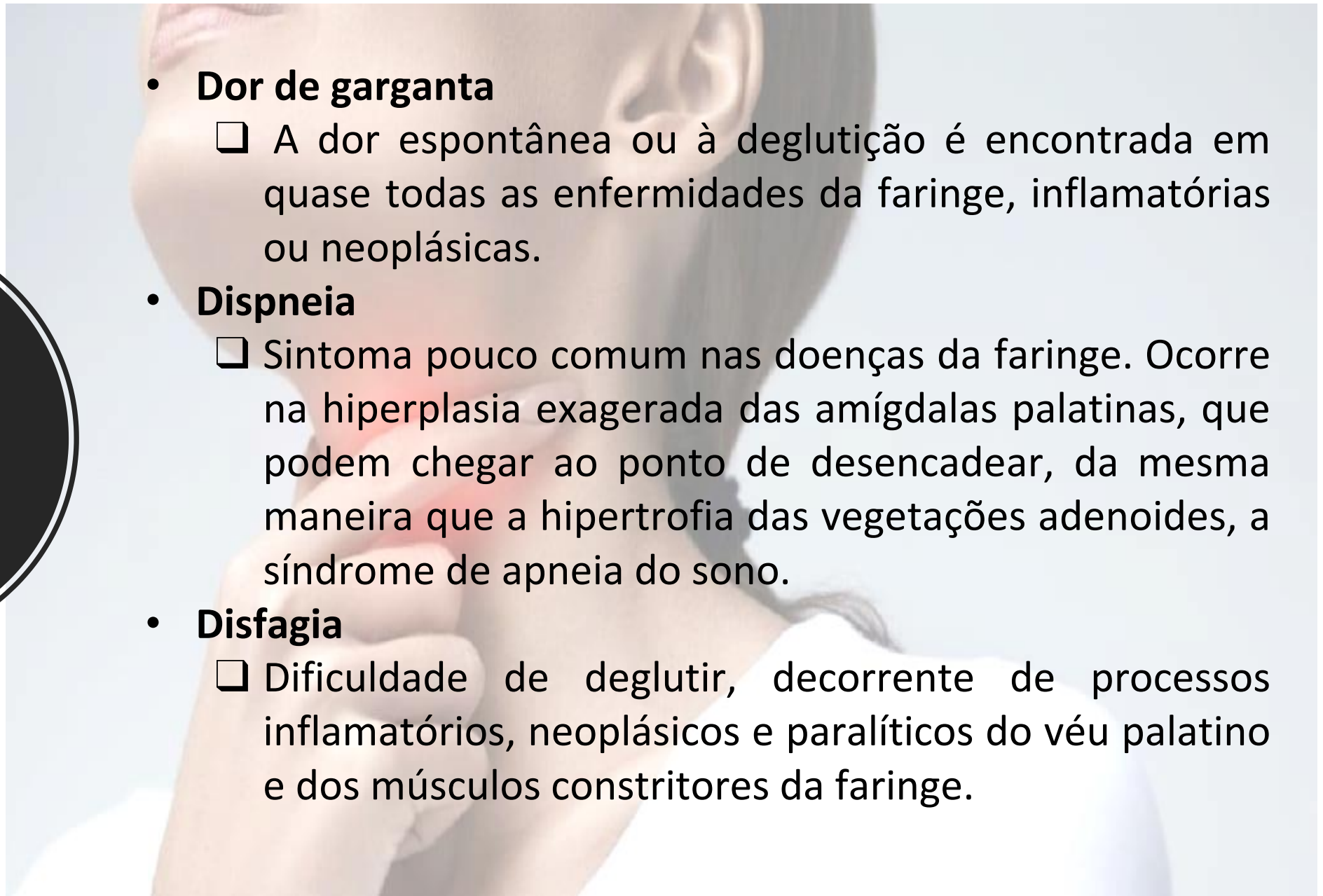
EXAME CLÍNICO

- Os dados de identificação são importantes na avaliação clínica dos pacientes.
- Hábitos de vida podem tornar os quadros de faringotonsilites mais frequentes, destacando-se ambientes confinados ou não ventilados, convívio com tabagistas, frequentar escolas e/ou berçários cada vez mais cedo.

- Dor de garganta
- Dispneia
- Disfagia
- Tosse
- Halitose
- Xerostomia
- Sangramento gengival
- Úlceras aftosas recorrentes
- Úlceras que não cicatrizam
- Nódulos, vesículas, bolhas, manchas e placas

SINAIS E SINTOMAS

- **Dor de garganta**
 - ❑ A dor espontânea ou à deglutição é encontrada em quase todas as enfermidades da faringe, inflamatórias ou neoplásicas.
- **Dispneia**
 - ❑ Sintoma pouco comum nas doenças da faringe. Ocorre na hiperplasia exagerada das amígdalas palatinas, que podem chegar ao ponto de desencadear, da mesma maneira que a hipertrofia das vegetações adenoides, a síndrome de apneia do sono.
- **Disfagia**
 - ❑ Dificuldade de deglutir, decorrente de processos inflamatórios, neoplásicos e paralíticos do véu palatino e dos músculos constritores da faringe.



SINAIS E SINTOMAS

- **Tosse**
 - ❑ A hiperplasia amigdaliana pode desencadear tosse reflexa.
- **Halitose**
 - ❑ Determinadas tonsilas palatinas podem transformar-se em depósito de detritos alimentares e produtos de descamação do próprio epitélio das tonsilas, dando origem às “massas caseosas” que são pequenas formações esbranquiçadas ou brancoamareladas.
- **Xerostomia**
 - ❑ Também conhecida como boca seca. As causas mais frequentes são as condições que desidratam a boca e ressecam a mucosa bucal, dentre as quais incluem-se a respiração bucal e o ronco, uso excessivo da fala e a desidratação de qualquer causa.



SINAIS E SINTOMAS

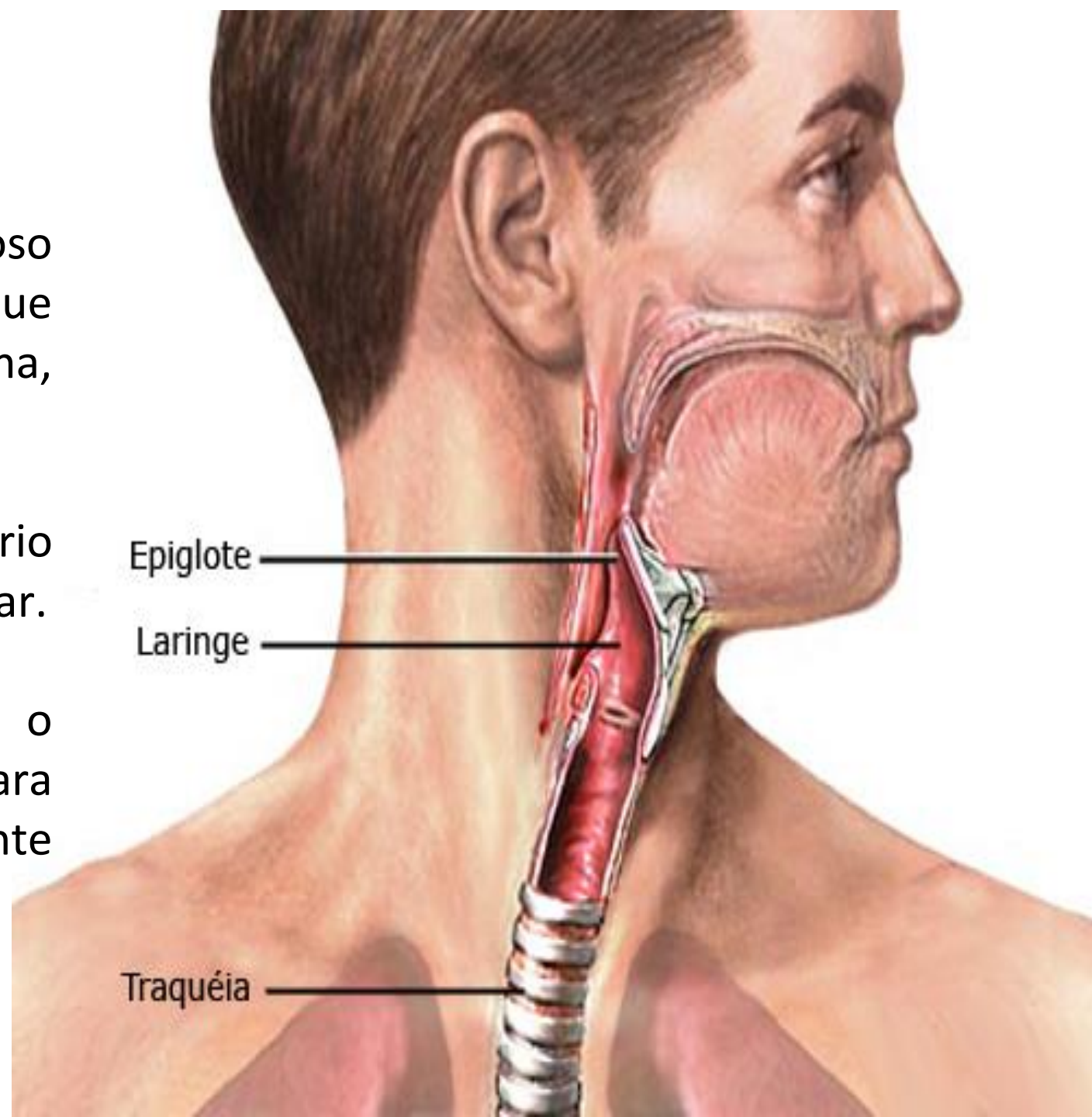
- **Nódulos, vesículas, bolhas, manchas e placas**
 - ❑ Nódulos - processos proliferativos não neoplásicos (hiperplasia fibrosa inflamatória, lesão periférica de células gigantes e granuloma piogênico), neoplasias benignas (fibroma, osteoma, adenoma pleomórfico, papiloma escamoso e lipoma) e relacionadas com o desenvolvimento, tais como o toro ósseo palatino e mandibular. São lesões bem delimitadas que apresentam superfície lisa, mas que podem apresentar sinais inflamatórios.
 - ❑ Vesículas e bolhas - manifestações de doenças de natureza infecciosa, traumática ou autoimune. As manifestações clínicas do herpes, por exemplo, localizadas na região perioral podem se manifestar como vesículas e bolhas dolorosas.

Laringe e Traqueia

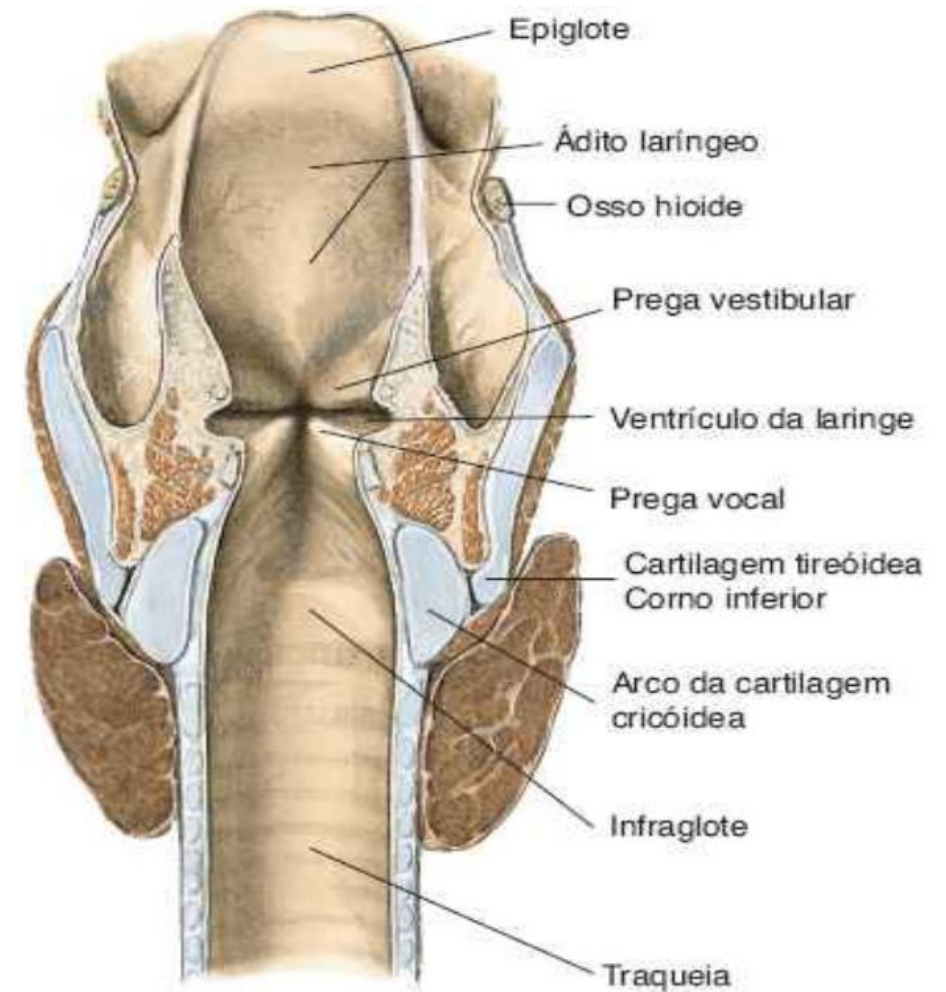
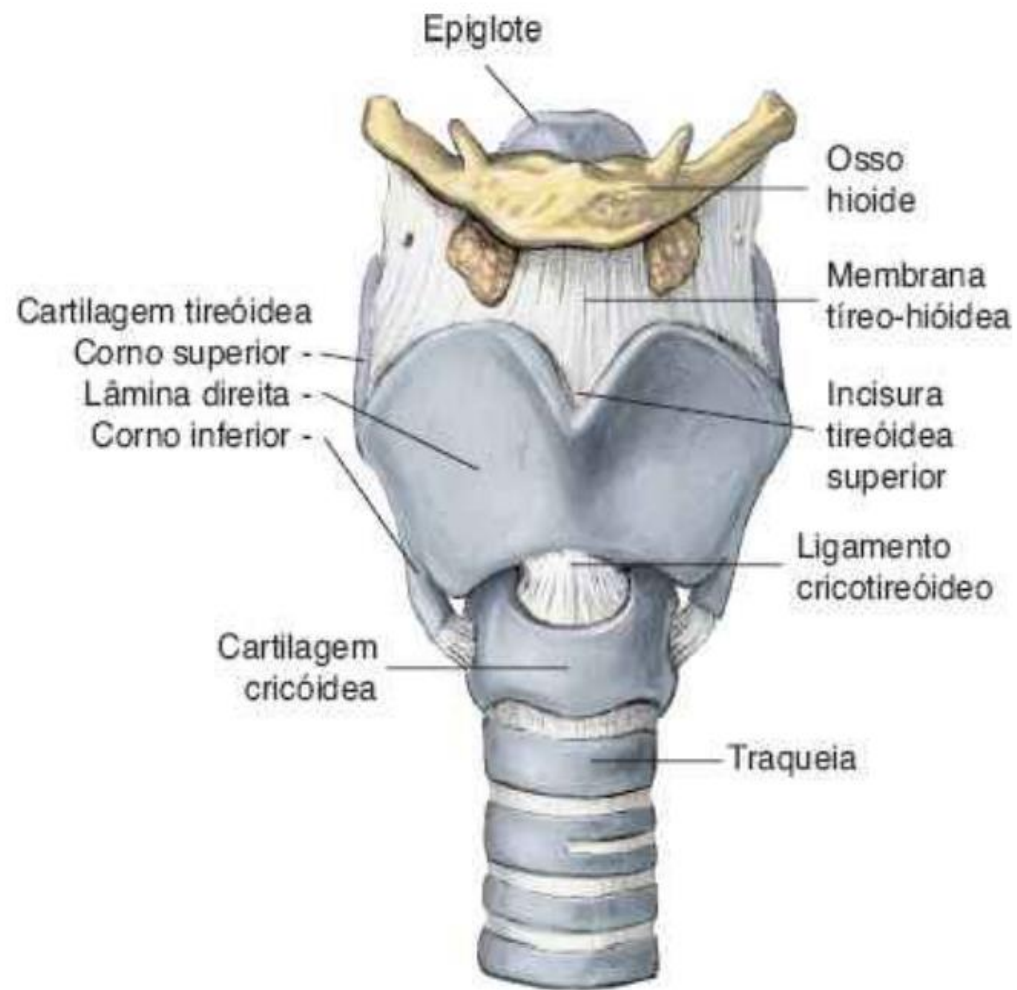
A laringe é um órgão musculocartilaginoso situado na região infrahióidea, que desempenha três funções: esfincteriana, respiratória, fonatória.

A traqueia é parte do trato respiratório inferior, função primordial a condução do ar.

Ao penetrar o tórax, considerando-se o paciente em pé, direciona-se de cima para baixo, um pouco para trás e ligeiramente para a direita.

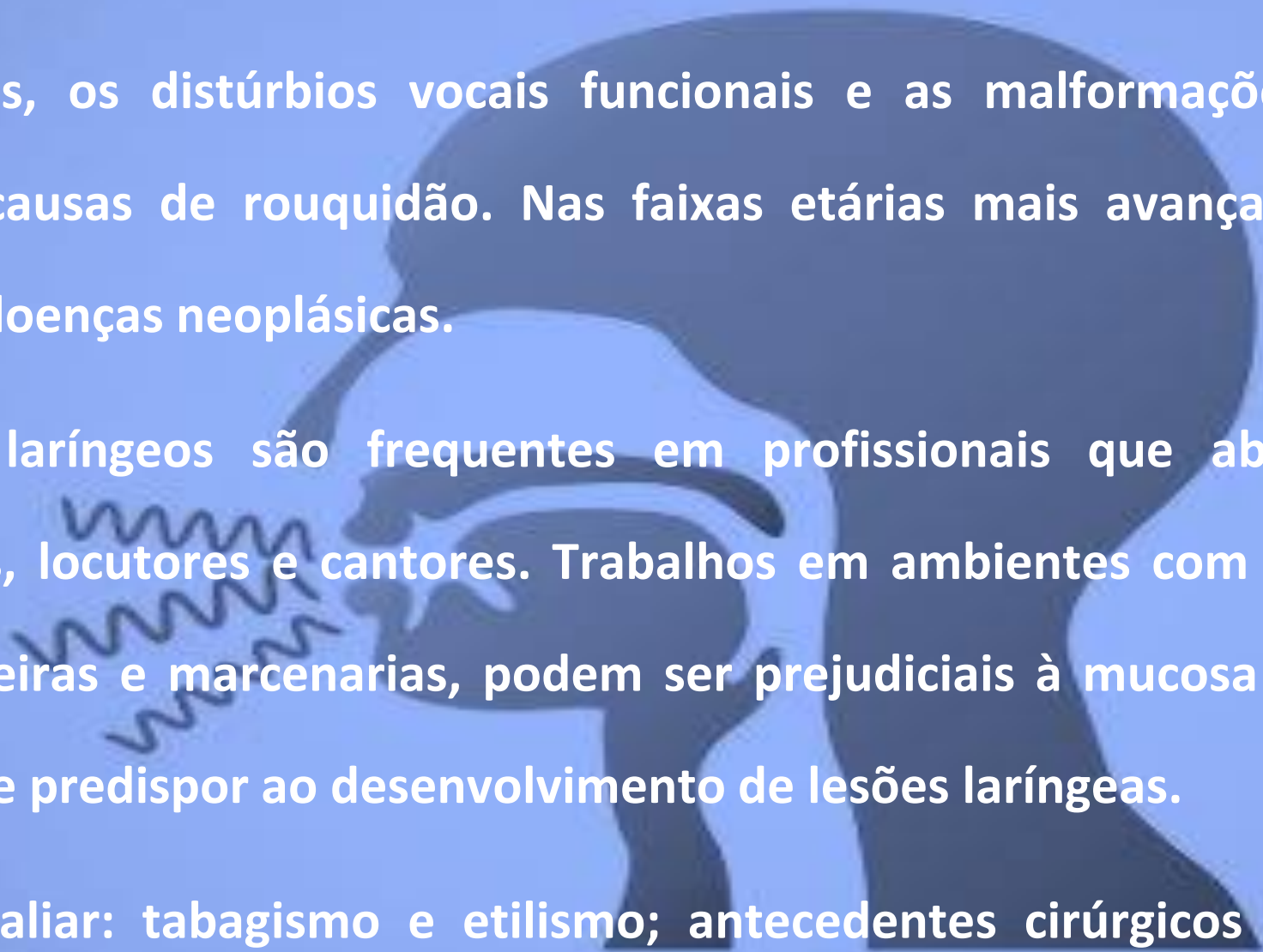


Laringe e Traqueia



EXAME CLÍNICO

- Em crianças, os distúrbios vocais funcionais e as malformações congênitas são as principais causas de rouquidão. Nas faixas etárias mais avançadas, são as laringites crônicas e doenças neoplásicas.
- Distúrbios laríngeos são frequentes em profissionais que abusam da voz, como professores, locutores e cantores. Trabalhos em ambientes com poluentes inalatórios, como pedreiras e marcenarias, podem ser prejudiciais à mucosa das vias respiratórias superiores e predispor ao desenvolvimento de lesões larígeas.
- Deve-se avaliar: tabagismo e etilismo; antecedentes cirúrgicos (sintomas vocais que aparecem no pós-operatório).





SINAIS E SINTOMAS

- **Rouquidão** - caracteriza-se pela mudança do timbre e da intensidade da voz.
 - ❑ Início: Alterações súbitas da voz podem indicar distúrbios emocionais (disfonia psicogênica) ou doenças neurológicas, como paralisia de pregas vocais. História mais arrastada, de evolução progressiva, costuma ser observada em neoplasias.
 - ❑ Frequência: Distúrbios funcionais ocorrem, em geral, em períodos de abuso vocal. Já os distúrbios vocais orgânicos têm rouquidão fixa, sem momentos de melhora.
 - ❑ Sintomas associados: Otalgia reflexa e odinofagia, que são indicativos de tumores supraglóticos com extensão para hipofaringe; tosse e desconforto respiratório são encontrados em tumores glóticos volumosos com extensão para a subglote.



SINAIS E SINTOMAS

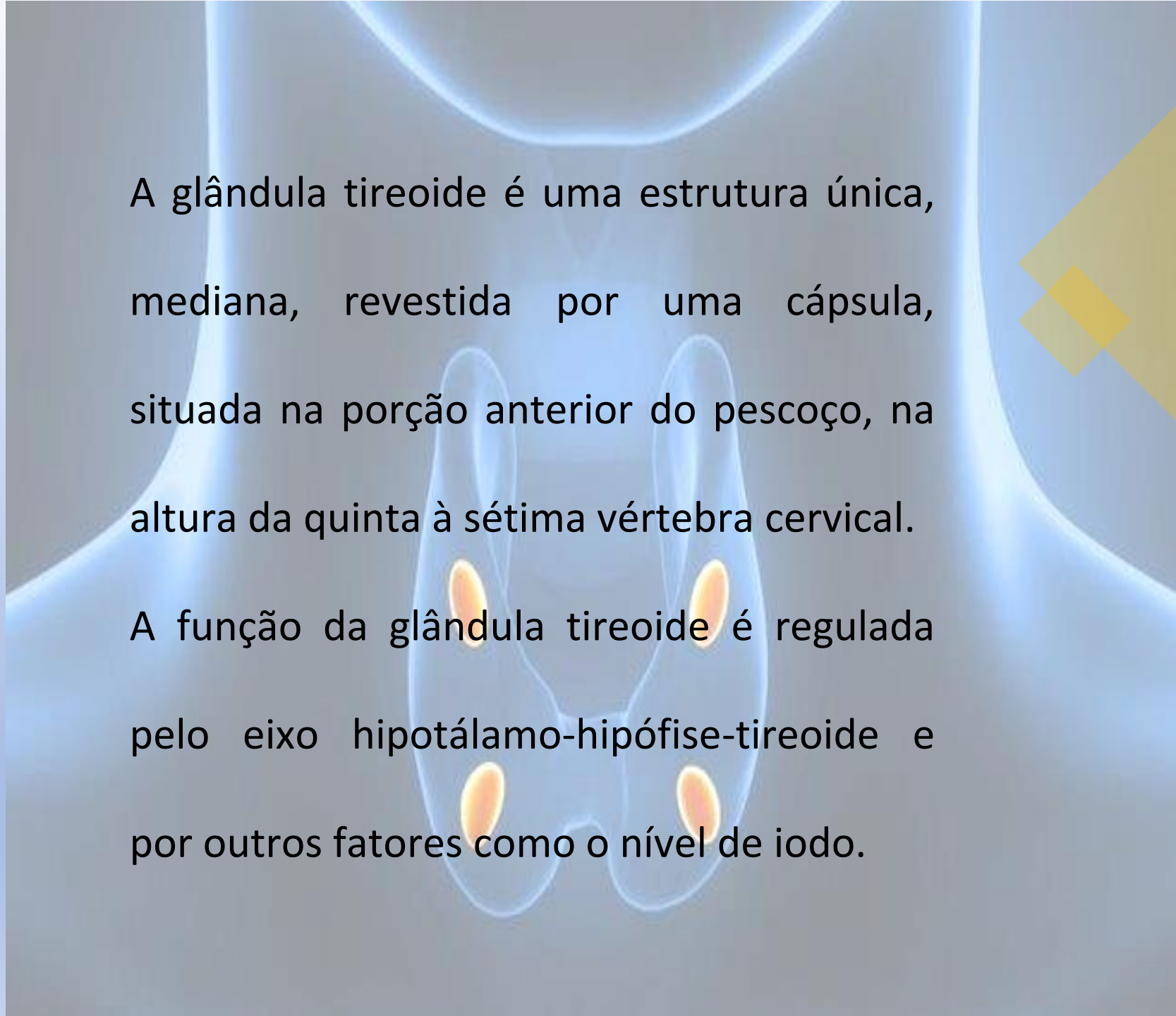
Estridor - som produzido pelo turbilhonamento do ar quando há qualquer tipo de restrição nas vias respiratórias superiores.

- Tipo do estridor: Inspiratório e expiratório / ambos.
- Época de início: Desde o nascimento, ou primeiras semanas de; após intubação orotraqueal e/ou internação em unidades de tratamento intensivo.
- Sintomas associados: Aparecimento abrupto em crianças sem febre (aspiração de corpo estranho); a presença de febre levanta a suspeita de laringite aguda.
- Periodicidade: Constante ou intermitente.
- Fatores de melhora ou piora: Na laringomalacia, por exemplo, é característico que o estridor piore aos esforços físicos, choro e mamadas.
- Sinais respiratórios indicativos de gravidade: Taquipneia com retração do tórax; retração de fúrcula e costal; apneia; uso da musculatura acessória.

Tireoide e Paratireoides

A glândula tireoide é uma estrutura única, mediana, revestida por uma cápsula, situada na porção anterior do pescoço, na altura da quinta à sétima vértebra cervical.

A função da glândula tireoide é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e por outros fatores como o nível de iodo.

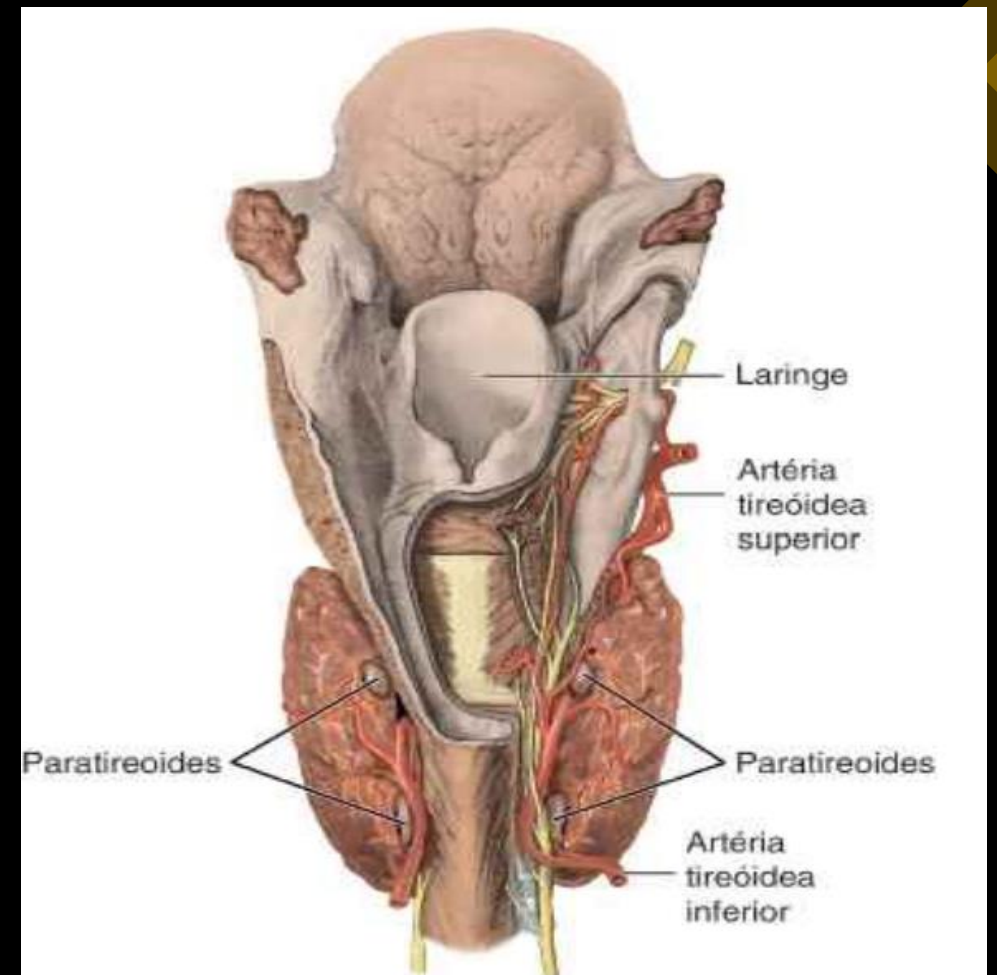
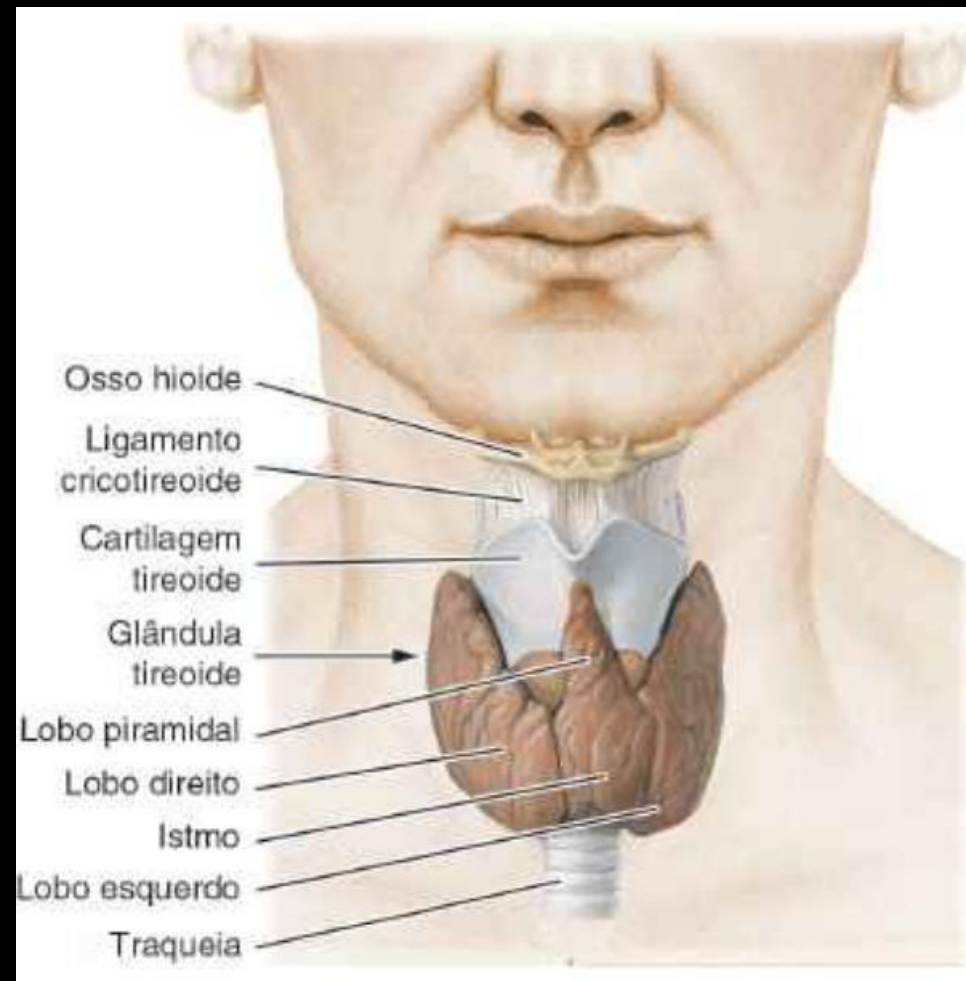


Tireoide e Paratireoides

As paratireoides, quase sempre em número de quatro, situam-se atrás da tireoide, acopladas à sua face posterior, na altura dos polos inferiores e superiores de cada lobo.

As paratireoides secretam continuamente o hormônio paratireoidiano ou paratormônio, um polipeptídio cujas principais funções estão relacionadas com o metabolismo do cálcio e as unidades metabólicas dos ossos.

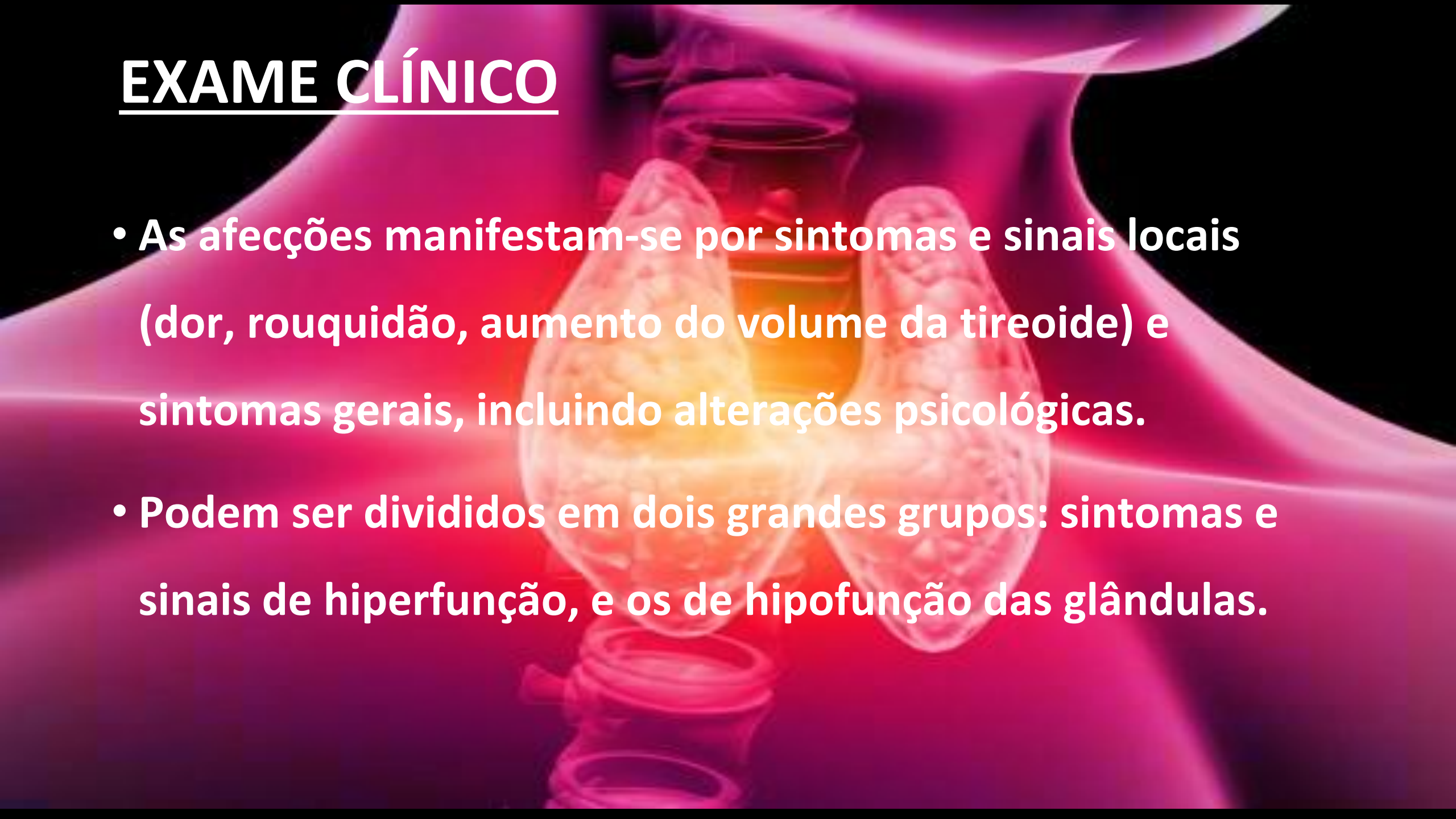
Tireoide e Paratireoide



EXAME CLÍNICO

- As doenças tireoidianas são mais frequentes nas mulheres e surgem em faixas etárias distintas. Os bócios multinodulares, por exemplo, ocorrem predominantemente após a quarta década de vida.
- Os sinais e sintomas das doenças das paratireoides dependem do distúrbio funcional, que pode ser dividido em estado de hipofunção e hiperfunção. Em ambas as condições, ocorrem alterações do metabolismo do cálcio e do fósforo, bem como das unidades metabólicas dos ossos.

EXAME CLÍNICO



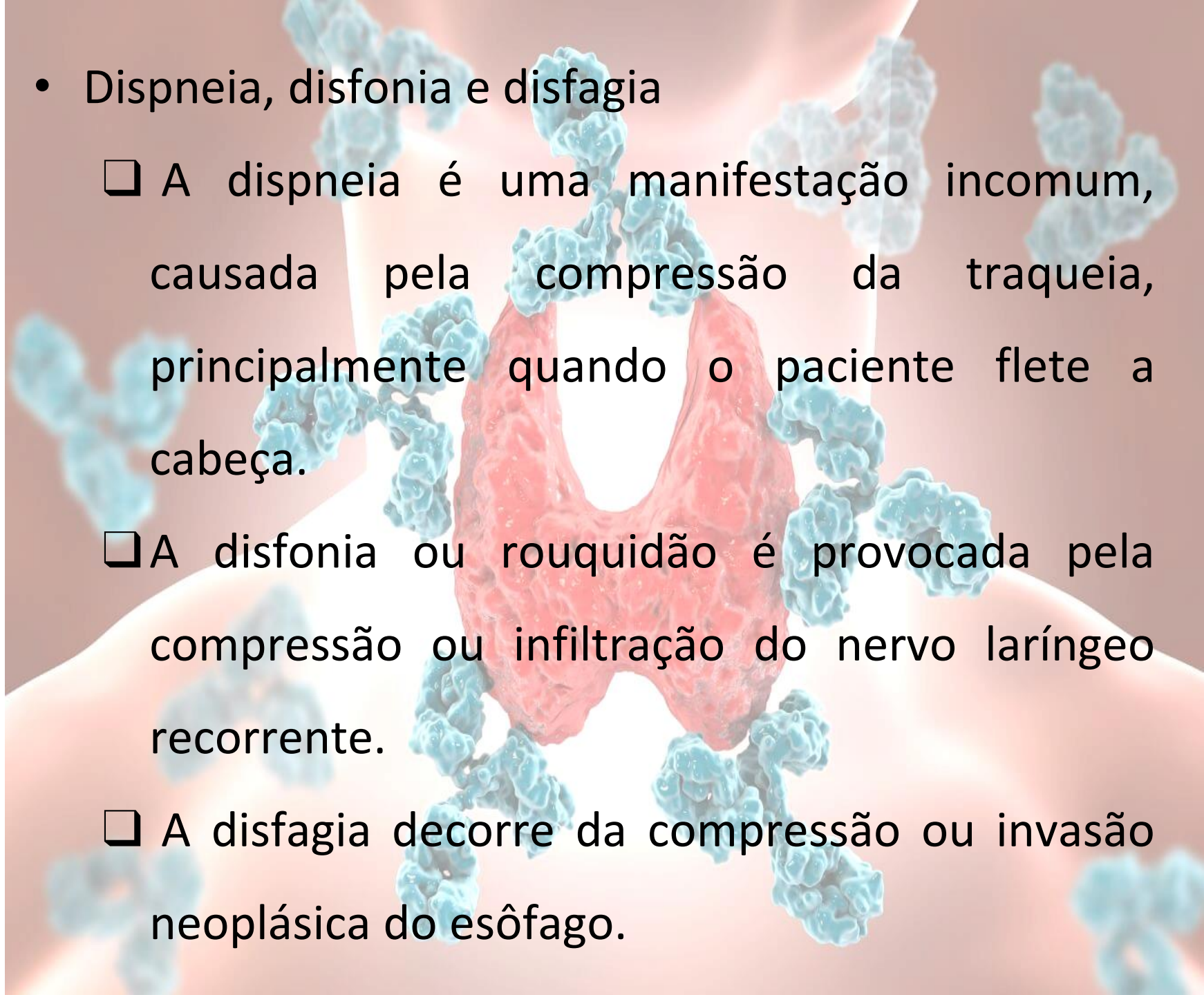
- As afecções manifestam-se por sintomas e sinais locais (dor, rouquidão, aumento do volume da tireoide) e sintomas gerais, incluindo alterações psicológicas.
- Podem ser divididos em dois grandes grupos: sintomas e sinais de hiperfunção, e os de hipofunção das glândulas.

SINAIS E SINTOMAS

- **Dor**

- ☐ Sua causa principal é a tireoidite aguda ou subaguda. Mais raramente, pode ser ocasionada por hemorragia ou necrose de um nódulo tireoidiano.

- ☐ As principais características semiológicas da dor de origem tireoidiana são: piora com a deglutição ou com a palpação; irradiação para os arcos mandibulares ou ouvidos, acompanhada de aumento do volume da glândula, sintomas de hipertireoidismo, febre baixa e mal-estar geral.



SINAIS E SINTOMAS

- Dispneia, disfonia e disfagia
 - ❑ A dispneia é uma manifestação incomum, causada pela compressão da traqueia, principalmente quando o paciente flete a cabeça.
 - ❑ A disfonia ou rouquidão é provocada pela compressão ou infiltração do nervo laríngeo recorrente.
 - ❑ A disfagia decorre da compressão ou invasão neoplásica do esôfago.

Manobras e Sinais Clínicos

Manobra de Pemberton

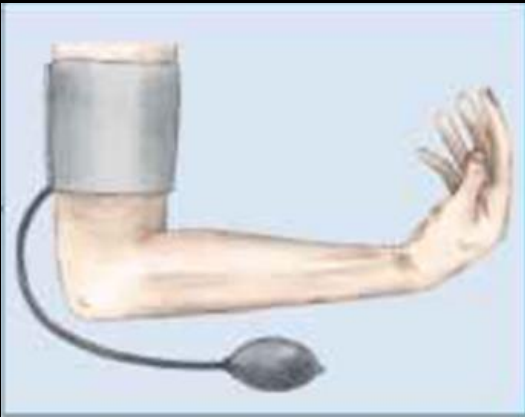
Pesquisa de bócio mergulhante.

Pede-se ao paciente para elevar os braços, paralelos a cabeça, com pescoço estendido.

Pode fazer o bócio aflorar à fúrcula esternal, além de promover congestão venosa por presença do bócio.



Manobras e Sinais Clínicos



SINAL DE TROUSSEAU

Pode ser provocado ao se manter o manguito do aparelho de pressão insuflado, por 3 min, 20 mm de mercúrio acima da pressão sistólica do paciente.

Nos casos de hipocalcemia, ocorrem flexão do punho, extensão das articulações interfalangianas e adução do polegar, configurando o que se costuma chamar de “mão de parteiro”.

SINAL DE CHEVOSTEK

Pesquisado pela percussão do nervo facial, adiante do pavilhão auditivo. Quando há hipocalcemia, aparece contração da musculatura da face e do lábio superior no lado em que se fez a percussão.

É importante ressaltar que o sinal de Chvostek ocorre em 10% da população normal.

“ Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito. ”

Aristóteles

REFERÊNCIAS

1. Exame Clínico- Celmo Celeno Porto - 8ª Edição. 2017. Editora Guanabara Koogan. (pag: 603 - 655)
2. Bates - Propedêutica Médica - Lynn S. Bickley. 13ª Edição. 2022. Editora Guanabara Koogan (pag: 689-868)
3. Semiologia Médica – Celmo Celeno Porto. 8ª Edição. 2019. Editora Guanabara Koogan. (pag: 307-368;985-1018)
4. Semiologia Médica –José Rodolfo Rocco. 1ª Edição.2010. Elsevier Editora. (pag: 36-70)